

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: OLIMPIA ISABEL MARTINEZ DE GUTIERREZ	H.C: 42496695
EDAD: 70 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 3/12/1954
ESCOLARIDAD: Tercer Grado	FECHA DE EVALUACIÓN: 29,30/10/2025
DIRECCION: Calle 28 # 4-48 Barrio Villa del rosario	CORREO: sandritaguti_25@hotmail.com
EPS: Particular	EVALUADOR: Jainer Guzmán Vega
ACOMPAÑANTE: Hermana, hija	CELULAR: 3016264166

2. MOTIVO DE CONSULTA

Paciente refiere, se me olvidan mucho las cosas.

3. ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución hace dos años con agudización desde hace 12 meses caracterizado por olvidos frecuentes como olvidar lo que iba hacer, no conoce algunos rostros familiares, algunas veces olvida donde deja el dinero, dice expresiones como me están cogiendo las cosas, repite las cosas varias veces por que las olvido, necesita apoyo para la ingesta de medicación, olvida el nombre de personas conocidas, en ocasiones olvida que está haciendo algo en la cocina, ha perdido la motivación de ir a la iglesia, casi no le gusta salir, olvida información reciente, episodios de desorientación, olvida citas, algunas conductas de irritabilidad, no sale sola, no maneja dinero.

4. ANTECEDENTES MEDICOS PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: HTA

Quirúrgicos: Si.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

Medicamentos: Losartán – HTA - Memantina, cognición – Memoria.

TAC: 13/11/2024: Aumento de las cavidades que tienen liquido cefalorraquídeo, retracción cefálica, difusa cortical y central acorde a su grupo etario.

Pequeñas lesiones hipodensas a nivel de sustancia blanca subcortical frontoparietal, probable secuelas isquémicas.

5. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción. No reporta

Epilepsia: No reporta

Alzheimer: No reporta

6. HISTORIA EDUCATIVA.

La paciente presenta poca claridad al momento de expresar su nivel educativo. Refiere haber cursado estudios de educación básica primaria, señalando que alcanzó



aproximadamente el grado tercero; sin embargo, no se cuenta con certeza ni respaldo documental que confirme dicho nivel. Se observa que el paciente tiene dificultades para precisar detalles sobre su trayectoria escolar, mostrando vacilación y escasa información sobre instituciones o años de estudio. No se reporta continuidad académica posterior ni participación en procesos de formación complementaria.

7. HISTORIA LABORAL.

Durante la entrevista, la paciente manifiesta dificultad para recordar aspectos relacionados con su historia laboral, refiriendo no tener claridad respecto a si desempeñó algún trabajo en el pasado. Ante esta situación, se recurre a información complementaria proporcionada por su hermana, quien indica que la paciente administró un restaurante en años anteriores. No obstante, aclara que hace más de diez años dejó de dedicarse a dicha labor. Esta dificultad para evocar información autobiográfica reciente y remota sugiere alteraciones en la memoria episódica asociadas a la evocación de experiencias personales y contextuales.

8. HISTORIA FAMILIAR Y SOCIAL

La paciente reside junto a su esposo, una de sus hijas y dos nietos, con quienes mantiene adecuadas relaciones interpersonales, mostrándose colaboradora y afectiva dentro del entorno familiar. Refiere haber tenido cuatro hijos y se observa una relación familiar armónica con todos ellos. Sin embargo, durante la entrevista presenta dificultades para evocar con claridad los nombres de sus hijos e incluso el número total de los mismos, evidenciándose fallas en la recuperación de información autobiográfica y en la evocación de datos familiares significativos, lo que sugiere compromiso en la memoria episódica y semántica personal.

9. HISTORIA SOCIAL.

En la actualidad, la paciente presenta una disminución significativa en su participación social. Refiere que anteriormente disfrutaba de realizar actividades fuera del hogar, como asistir con frecuencia a la iglesia y visitar a familiares, especialmente en situaciones de apoyo o calamidad. Sin embargo, menciona que ha dejado de hacerlo progresivamente, mostrando una reducción en el interés y la iniciativa para involucrarse en actividades que antes le resultaban gratificantes y significativas. Esta disminución en la motivación y en la interacción social puede estar asociada a alteraciones emocionales y a un posible retraimiento social secundario a cambios en su estado anímico o en sus funciones ejecutivas.

10. HISTORIA SOCIOAFECTIVA

Paciente sin antecedente depresivos, ansiosos, se denota tranquila, pero con tendencia a la bradilalia, bradipsiquia.

11. DOMINIOS

++Dominio Conceptual: Dificultad para retener información a corto plazo (x), lenguaje fluido sin alteraciones (+), Manejo del tiempo y espacio (+), Manejo del dinero (+). [1/6]



++Dominio Social: Pocas relaciones sociales debido a la edad (+), Comunicación, lenguaje y la conversación espontánea y lógica (+), Dificultad en la regulación de las emociones y el comportamiento (+), comprensión del riesgo en situaciones sociales (+), juicio social maduro (+), no influenciable (+). [6/6]

++Dominio Práctico: Nivel adecuado en el cuidado y aseo personal (+), autonomía en el vestirse (+), autonomía en el comer (+), no necesita ayuda en actividades de la vida cotidiana complejas en comparación con sus pares (+), No Necesita ayuda en el juicio relacionado con bienestar y organización del ocio (+). [6/6]

12. CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, se muestra alerta, motivada, entusiasta, adecuada higiene postural, orientada auto y desorientada alopsiquicamente, lenguaje y pensamiento fluido, bradilalia bradipsiquia, problemas en memoria episódica, no fallas comprensivas, juicio y raciocinio desviado, inteligencia aparente normal, no restricciones en la locomoción, se muestra colaboradora.

13. PRUEBAS APLICADAS

Protocoló neuropsicológico para valoración de las funciones mentales superiores: Mini Mental State Examination (MMSE) Memoria: (Curva de memoria semántica con incremento asociativo - Memoria lógica - pares asociados - reproducción visual -Figura Rey - Evocación) - Atención: (Prueba de ejecución auditiva continua - Prueba de ejecución visual continua - T.M.T-A/B, control mental) - Lenguaje: (FAS fonológico y semántico - Token test) - Praxias: (Figura compleja de rey copia - Praxias ideacionales e ideomotoras). Funciones ejecutivas: Criterios DSM V y CIE 10 - Mini mental - Escala de depresión Yesavage - Escala de AVD e Instrumentales) - Escala Global de deterior. (EDG).

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
MINIMENTAL		
Orientación y Tiempo	0	5
Orientación y lugar	2	5
Memoria de fijación	3	3
Atención y Calculo	5	5
Memoria de Evocación	0	3
Denominación	2	2
Repetición	1	1
Comprensión	2	3
Lectura	0	1
Escritura	0	1
Copia de dibujo	0	1
Total	15/28.58	30 DETERIORO COGNITIVO LEVE



Las puntuaciones obtenidas reflejan un patrón anormal de 15 de 30/ con promedio de 28.58 lo cual es un punto débil normativo.

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
EJECUCION AUDITIVA CONTINUA	15/15.20 Errores: 1	[NORMAL]
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
EJECUCION VISUAL CONTINUA	16/15.20 Intrusión: 0	[NORMAL]

Mide las respuestas en la velocidad de procesamiento y efectividad de las respuestas, establece datos normativos de los procesos atencionales: atención focalizada, sostenida y alternante. Errores ejecutivos: errores de omisión, errores perseverativos, distribución de los recursos atencionales a diferentes tareas o requisitos de una misma tarea.

ESCALA DE MEMORIA WECHSLER		
SUB-PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
INFORMACION	1/5.70	SD 0.40 [ANORMAL] SD - +4
ORIENTACION	2/5	SD 0 – SD [ANORMAL] – SD - +4
Mide la orientación alopsíquica y autopsíquicas, si existe alteración en los dos procesos existe alteración global de la orientación.		
CONTROL MENTAL	6/6.61	SD 1.90 – SD [NORMAL]
Se relaciona con los procesos de la memoria de trabajo, operaciones mentales en línea a corto plazo, memoria semántica, velocidad de respuesta manteniendo la atención sin interferencia.		
MEMORIA LOGICA	A: 0/8.65 B: 0/7.54	SD 3.46 [ANORMAL] – SD -1 SD 2.66 [ANORMAL] – SD -2
SUMA	0/8.09	SD 2.52 [ANORMAL] – SD -1
Mide la memoria sensorial ecoica, capacidad de registro, almacenamiento y evocación, capacidad en la memoria a corto plazo, capacidad de aprendizaje, habilidad auditiva verbal, capacidad de almacenamiento semántico, span de memoria, capacidad de relación lógica, información organizada.		
DIGITOS		
PROGRESION	5/5.98	SD 1.90 [NORMAL]
REGRESION	0/4.30	SD 1.11 [ANORMAL] – SD -3
Establece medida de los procesos atencionales que requieren esfuerzo cognitivo, memoria de trabajo, memoria inmediata, indicando habilidades de secuenciación, planificación, alerta y flexibilidad cognitiva, span verbal y auditivo.		
REPRODUCCION VISUAL	0/8.35	SD 3.17 [ANORMAL] SD - 1



Evalúa la capacidad de los recuerdos inmediato de estímulos visuales, capacidad de atención sostenida, focalizada, memoria que almacena o retiene información perceptiva, en este caso visual, para trabajar con ella, capacidad de organización y dar sentido a las cosas.		
PARES ASOCIADOS	Fácil: 2/ 8.26 Difícil: 0/5.70	SD 0.24 [ANORMAL] SD - +4 SD 2.73 [ANORMAL] SD - 1
SUMA	2/13.912	SD 3.12 [ANORMAL] SD -3
Tiempo requerido para almacenar y evocar información con relación semántica, evocación verbal a corto plazo de pares asociados. Capacidad de discriminación de palabras asociadas.		
MEMORIA SEMANTICA CON INCREMENTO ASOCIATIVO	PEV:0/16 SEV: 0/16 [ANORMAL], EV.DIR: 0/16 EV.DIR.DIF´20: 0/16 [ANORMAL]. La paciente no lora evocar en tres presentaciones os dibujos relacionados con elemento de cocina.	
Evalúa la capacidad de aprendizaje de nuevos conocimientos - visuales, la capacidad de interpretar en poco tiempo, y con pocas palabras. Evalúa el componente semántico, relacionado con la actividad de los circuitos hipocampales de la memoria. Permite almacenar información acerca del significado de los objetos, las palabras y del mundo en general.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
Figura De Rey copia	Puntuación: 0/26,39 Tiempo: 260/337,63	[ANORMAL] SD 7,25 – SD - 1 [NORMAL] SD 237,22
Evalúa la organización perceptual y la memoria visual, rastreo visual, atención sostenida – focalizada, organización perceptual. Praxias viso construccionales.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
Figura De Rey evocación	Puntuación: 0/11,13 Tiempo: 60/210,14	[ANORMAL] SD 7.11 – SD 1 [NORMAL] SD 163,21
Brinda información sobre el funcionamiento neuropsicológico. Evalúa los procesos de registro, almacenamiento y evocación de memoria a largo plazo. Capacidad de aprendizaje general memoria visual – organización.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
FAS FONOLOGICO	1/12,29	[ANORMAL] - SD - 3
Mide la habilidad de producción de palabras que inician con una letra o fonema y el aspecto semántico dentro de una categoría semántica determinada. Evaluación global del lenguaje y funciones ejecutivas, funciones cognitivas.		



TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
FAS SEMANTICO	3/16	[ANORMAL] – SD - 2
Evalúa la flexibilidad mental, la velocidad de procesamiento y el lenguaje. Pone a prueba los mecanismos necesarios para el acceso al léxico, evocación y denominación.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TOKEN TEST	19/34.62	[ANORMAL] SD 1.59 SD - +4
Evalúa la comprensión de ordenes de baja, mediana (dos comandos) y alta complejidad (tres comandos). Comprensión de ordenes con capacidad creciente. Evalúa la comprensión los verbos y las preposiciones incluidos en las instrucciones, sintaxis. Capacidad para comprender el nombre (circulo y cuadrado, color y tamaño).		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TMT A	Puntuación: 24/24 Tiempo: 200/96.88	[NORMAL] [ANORMAL] SD 46,66 – SD - 1
Evalúa las habilidades motoras, viso-espaciales de búsqueda visual y atención sostenida.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TMT B	Puntuación: 0/24 Tiempo: 480/253,49	[ANORMAL] [NORMAL] SD 162,80
Mide la velocidad de procesamiento, rastreo visual, atención alternante, divida, sostenida, flexibilidad mental del pensamiento, habilidades visoespaciales.		

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
PRAXIAS (IDEACIONALES)	CORPORALES	20/20
PRAXIAS (IDEOMOTORAS)	CORPORALES	40/40
		[NORMAL] [NORMAL]
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO	Claves: 0/1 Símbolos: 0/1	M/10[ANORMAL] M/10[ANORMAL]
Mide la velocidad de procesamiento, rastreo visual, atención alternante, divida, sostenida, flexibilidad mental del pensamiento, habilidades visoespaciales.		
ESCALAS	PUNTUACION	INDICADOR
INDICE DE BARTHEL	50/50	SIN DIFICULTAD
INDICE DE KATZ	2/6	INCAPACIDAD LEVE
YESAVAGE	0/15	SIN DEPRESIÓN
LAWTON Y BRODY	15/30	DEPENDENCIA MODERADA
ESCALA DE MEMORIA	QP: 33 QF: NA	DIFICULTAD SEVERA
ESCALA GLOBAL DE DETERIORO - EDG	4/7	DETERIORO COGNITIVO LEVE



PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE WISCONSIN

Mide organización, planificación, seguimiento de secuencia, flexibilidad, el cambio de tarea, o la inhibición, mantenimiento del principio, uso del feedback, capacidad para modificar estrategias incorrectas, resolución conceptual de problemas.

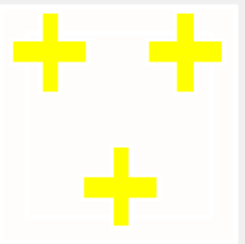
WCST: Prueba



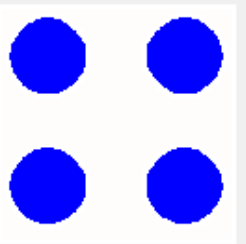
1



2



3



4



ítem **58**

Interrumpir

Prueba descontinuada debido a la demora en la respuesta de los reactivos, no logrando realizar ninguna categoría, le costó mantener le principio, olvidaba con facilidad lo que debía hacer.

14. RESULTADOS DE EVALUACIÓN:

ORIENTACIÓN:

ALTERADO: Orientación: Mini Mental State Examination: Desorientada auto y alopsiquicamente.

ALTERADO: Escala de memoria Wechsler: información, orientación: Desorientada alopsiquicamente.

ATENCIÓN:

ALTERADO: Atención: TMT-A: Se observa inadecuada velocidad de procesamiento,



atención alternante, Atención: TMT-A - B: ALTERADO: Inadecuada capacidad para distribuir los recursos atencionales a diferentes tareas o requisitos de una misma tarea, para seguir la instrucción de la tarea, con inadecuado control inhibitorio en el desarrollo de la actividad. Los procesos de atención sostenida se encuentran conservados, se observan errores de omisión y errores perseverativos.

ALTERADO: CLAVES – SIMBOLOS DEL WAIS 4: En estas prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para parear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.

CONSERVADO: Prueba de ejecución continua auditiva y visual: Se observa adecuadas respuestas en los procesos viso-espaciales de búsqueda visual y atención sostenida. No se observan dificultades de la velocidad de procesamiento, rastreo visual, atención alternante, divida, sostenida, flexibilidad mental del pensamiento.

CONSERVADO: Control mental: Se observan adecuado cambio en las estrategias de recuperación de la información.

CONSERVADO: Dígitos en progresión: Adecuados procesos atencionales que requieren esfuerzo cognitivo

MEMORIA:

ALTERADO: Memoria: (Escala de memoria de Wechsler III: Memoria lógica parte A: [] Memoria lógica parte B: Inadecuada memoria sensorial ecoica, inadecuada capacidad de registro, almacenamiento y evocación, alteración de los procesos de memoria a corto plazo, se observa deterioro significativo en la capacidad de aprendizaje, adecuadas habilidades auditivas verbales, inadecuada capacidad de almacenamiento semántico, span de memoria, de relación lógica, con aprendizaje de información desorganizada.

ALTERADO: Dígitos en regresión: Inadecuada respuestas en operaciones mentales en línea - memoria de trabajo alterada, memoria inmediata, indicando dificultades en los procesos de secuenciación, planificación, alerta y flexibilidad cognitiva, span verbal y auditivo.

ALTERADO: Reproducción visual: Inadecuada capacidad para almacenar los recuerdos inmediatos de estímulos visuales simples.

ALTERADO: Pares asociados: Dificultad para almacenar y evocar información con relación semántica, evocación verbal a corto plazo de pares asociados. incapacidad de discriminación de palabras asociadas.

ALTERADO: Memoria semántica con incremento asociativo: PEV: [], SEV: [], EV.DIR: [], EV.DIR.DIF: Inadecuada capacidad de aprendizaje de nuevos conocimientos - visuales, la de interpretar en poco tiempo, y con pocas palabras.

ALTERADO: Figura compleja de rey evocación: Inadecuado funcionamiento neuropsicológico, inadecuada capacidad de registro, almacenamiento y evocación de memoria a largo plazo, inadecuada capacidad de aprendizaje general memoria visual y organización.



CONSERVADO: Mini Mental State Examination: [Memoria de fijación]

[ALTERADO]. [Memoria de Evocación].

LENGUAJE:

CONSERVADO: Mini Mental State Examination: [Denominación] [Repetición] [Comprensión] [Lectura].

ALTERADO: [FAS fonológico: Se observa inadecuada habilidad de producción de palabras que inician con una letra o fonema y el aspecto semántico dentro de una categoría semántica determinada. ALTERADO: y semántico: Inadecuadas respuestas en cuanto a los mecanismos necesarios para el acceso al léxico, evocación y denominación.

ALTERADO: Token test: Inadecuada comprensión los verbos de acción – comando conservación de las preposiciones, no se observan instrucciones, adecuada sintaxis.

PRAXIAS – GNOSIAS:

Praxias viso constructivas [ALTERADO] - Praxias ideacionales: CONSERVADO [] e ideomotoras: CONSERVADO []

ALTERADO: Figura compleja de rey copia: Inadecuada capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o figura final, dificultad para copia, reproducción y construcciones.

CONSERVADO: Gnosias.

FUNCIONES EJECUTIVAS:

ALTERADO: FAS fonológico [] Inadecuado funcionamiento ejecutivo, funciones cognitivas, sin embargo, se evidencian perseveraciones, omisiones e intrusiones.

ALTERADO: Token test: Inadecuada comprensión de órdenes de alta complejidad (tres comandos) y orden creciente.

ALTERADO: [] Wisconsin: Inadecuada organización, planificación, seguimiento de secuencia, flexibilidad, el cambio de tarea, o la inhibición, le cuesta mantener el principio, uso del feedback, inadecuada capacidad para modificar estrategias.

Se observan inadecuadas capacidades de abstracción, formación de conceptos, mantenimiento y cambio de estrategias cognitivas como respuesta a los cambios que se producen en las contingencias ambientales, clasificación, razonamiento analógico y razonamiento serial.

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO:

ALTERADO: CLAVES – SIMBOLOS DEL WAIS 4: En esta prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para aparear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.



CONSERVADO: La ejecución durante todas las pruebas fueron ejecutadas por debajo del tiempo esperado, con alta dificultad para la efectividad de las tareas.

ESCALAS

Escala de trastornos de Memoria: QF:33 – QP: NA, dificultad severa memoria.

Escala Yesavage: En la escala de depresión, La paciente no evidencia síntomas correspondientes a una depresión, con una puntuación de 0/15.

Escala Barthel de AVD y alimentación: Puntaje: 50/50. No se observan alteraciones significativas u objeto de atención clínica relacionadas o que interfieren con la vida diaria y alimentación.

Escala de Lawton y Brody – Instrumental: Puntaje: 15/30. La paciente presenta dependencia de la autonomía relacionada con las actividades personales e instrumentales.

Índice de Katz – Incapacidad leve 3

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

G301 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER COMIENZO TARDIO.

CONCLUSION

Según análisis clínico, criterios diagnóstico CIE y evaluación de pruebas cognitivas se determina la existencia de perfil de enfermedad de Alzheimer, acelerado por secuelas angiopatías, con 1) desorientación alopsíquica y autopsíquica con mayor gravedad en la parte espacial, la paciente no es capaz de evocar el día de la semana, mes, año, día de nacimiento, no logra evocar quien es el presidente de Colombia, 2) se observó afectación en la memoria inmediata de gravedad severa, no logra evocar lista de palabras fijadas con anterioridad a unos 40 segundos, 3) se evidencio marcada alteración en la memoria lógica, no logra evocar información auditivo verbal, a acorto plazo, 4) existe afectación en la memoria de trabajo de gravedad severa, 5) alteración en memoria a corto y largo plazo de gravedad severa, 6) se denoto afectación en las praxias viso constructivas de gravedad de severa, 7) marcada afectación en la capacidad de aprendizaje, la cual no mejora con la repetición, se observaron algunas respuestas en la evocación de palabras de baja frecuencia, en la segunda y tercera evocación aun con apoyo parecía que no comprendía el ejercicio aun con la utilización de apoyo, evocando mas de 4 veces el inicio de la palabra que mencionaba el evaluador cuando debía evocar la palabra o par acompañante, 8) se observo alteración en la fluidez semántica y fonológica de gravedad severa, 9) así como alteración en la memoria semántica asociativa, 10) se observo marcada afectación en la velocidad de procesamiento de gravedad severa, tardando más de lo habitual en ejecutar las tareas por ejemplo del TMT A, algunas tareas como búsqueda de símbolos, claves, TMT B, no logro comprenderlas, 11) la paciente mostro marcada afectación en la comprensión de ordenes de baja, mediana y alta frecuencia, 12) se evidencio afectación en las funciones ejecutivas como planificación, organización, secuenciación, no mantiene el principio, marcadas conductas perseverativas, no logra responder de forma favorable a las contingencias ambientales, 13, afectación en las AVD de tipo moderado pero que no



designan el grado de demencia, 14) alteración de gravedad severa en memoria episódica prospectiva (Le cuesta recordar evento de la actualidad, desorientación, baja capacidad de evocación de información casi suministrada de form inmediata, olvida lo que esta haciendo en el momento, le cuesta realizar nuevos aprendizajes, le cuesta conseguir las cosas, no sabe donde las coloca, repite las cosas por que olvido decirlas, le cuesta saber el nombre de las personas, olvida lo que le acaban de decir, en ocasiones como tarda mas de lo habitual en responde olvida la consigna). 15) las características de poca conciencia de enfermedad establecen anosognosia.

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por qué existen dos o más procesos cognoscitivos comprometidos alterado que incluyen, 1) la memoria, 2) la alteración en aprendizaje, + 3) otro proceso cognoscitivo: sin que exista alteración en las actividades de la vida diaria instrumentales o de autocuidado y alimentación como: la capacidad para usar el teléfono, ir de compra, capacidad para manejar la medicación, conservación del auto cuidado y alimentación: vestido, desvestido, deposición, micción, locomoción.

Se recomienda a neurología enviar exámenes de tomografía por emisión de positrones, prueba de p-tau y el péptido beta amiloide.

DIFICULTADES:

Orientación auto psíquica.

Orientación alopsíquica.

Atención alternante

Atención sostenida y focalizada.

Memoria sensorial ecoica.

Memoria inmediata

Memoria de trabajo

Memoria semántica

Memoria episódica

Memoria visual a corto y largo plazo.

Memoria auditiva verbal a corto y largo plazo.

Capacidad de registro, almacenamiento y evocación auditivo verbal y visual.

Seguimiento de instrucciones.

FAS fonológico y semántico

Velocidad de procesamiento.

Funciones ejecutivas

Lenguaje: repetición, comprensión, lectura (Denominación, sintaxis).

Praxias

Gnosias

Dependencia severa relacionada con las actividades personales e instrumentales.

HABILIDADES CONSERVADAS.

Memoria de fijación

Memoria a largo plazo tipo implícita procedimental, habituación.

AVD y alimentación.



PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta por neuropsicología en tres meses.

Evaluación por neuropsicología en 12 meses para determinar curso de la enfermedad.

Rehabilitación por neuropsicología 2 veces por semana que incluye: Hacer ejercicios de memoria a corto y largo plazo tipo visual y auditivo verbal, seguimiento de instrucciones de alta frecuencia, capacidad de aprendizaje, praxias, gnosias, calculo, lectura, escritura, fluidez fonológica y semántica, memoria inmediata y AVD instrumentales.

Rehabilitación dos veces por semana durante dos meses desde terapia ocupacional que permita mantener las AVD - independencia.

El paciente no está en facultad de cuidar si mismo u otros, así como también de tener responsabilidades que puedan afectar su integridad y las de otras personas

Seguimiento a cambios de comportamiento por medicación, (determinar).

Ajustar medicación según considere el especialista por neurología.

Apoye en todas las decisiones.

No lleve la contraria en lo posible.

Pregunte todos los días en la mañana como se siente, como esta, se siente bien, te amamos, eres importante para nosotros por lo menos dos veces al día.

Colóquele responsabilidad como organizar fiestas, llamar invitados u otros.

Incentive en casa crear cosas como juegos desde cero con cartón u otro elemento, no la excluya, intégreala a las reuniones.

Establezca dispositivos de localización para evitar que se pierda si existe poco monitoreo familiar. (lola gps).

Realizar actividades sencillas de memoria: mirar álbumes familiares, identificar personas, recordar rutinas o hechos positivos del pasado.

Mantener una rutina estructurada de actividades (levantar, comer, descansar, dormir a horas fijas).

Usar juegos cognitivos adaptados: rompecabezas grandes, dominó, bingo visual, asociación de imágenes, colorear, clasificar objetos.

Escuchar música conocida o canciones de su época, que estimulan la memoria emocional.

Estimular la orientación: señalar día, mes, año, estación y lugar diariamente con calendarios visibles.



Mantener los espacios bien iluminados y sin obstáculos para evitar caídas.

Colocar rótulos o imágenes en puertas (baño, cocina, habitación) para facilitar la orientación.

Retirar alfombras sueltas, cables o muebles con esquinas peligrosas.

Mantener objetos cotidianos (ropa, utensilios, medicinas) en lugares fijos y visibles.

Asegurar puertas o ventanas si hay riesgo de deambulación.

Hablar con voz suave, mirándole a los ojos y usando frases cortas.

No discutir ni corregir constantemente; es mejor redirigir la conversación con calma.

Ofrecer afecto, contacto físico tranquilo (tomar la mano, abrazar si lo acepta).

Fomentar la participación en tareas simples: doblar ropa, regar plantas, poner la mesa.

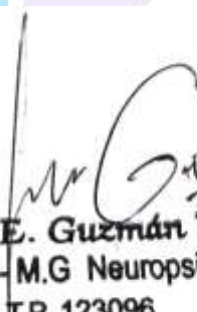
Mantener el contacto con familiares o amigos cercanos, incluso por videollamadas cortas.

Supervisar la alimentación balanceada y la hidratación (de 6 a 8 vasos de agua al día).

Promover caminatas cortas o ejercicios suaves según sus capacidades.

Vigilar la adherencia al tratamiento médico, con horarios y dosis visibles o supervisadas.

Observar cambios de conducta, sueño o apetito, y reportarlos al médico.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096
U.S.B. - Medellín

Firma

Nombre del Profesional: Jainer Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad San buenaventura de Medellín

No. Tarjeta Profesional:123096

